Passo, Baguala, Ambon, Indonesia

El Niño datang ke Passo sebagai musim kemarau yang panjang, dan bahayanya muncul sesudahnya: air yang ditampung selama kekeringan menjadi tempat berkembang biak nyamuk demam berdarah dengue (DBD), dan pasien DBD di Maluku meninggal dengan angka tertinggi di Indonesia. Siapkan puskesmas untuk menangani DBD, dan dorong Wali Kota menetapkan status darurat kekeringan agar air dan dana bergerak sebelum November.

WILAYAH DAMPAK	KELEBIHAN KEMATIAN AKIBAT PANAS	PERIODE	BAHAYA UTAMA
Tidak tersedia pada resolusi ini. Wilayah induk: Kota Ambon (357.289 jiwa, pertengahan 2024)	Indonesia 19.300 (10.400 pada Des–Feb). Kota Ambon ~24 berdasarkan penskalaan jumlah penduduk, hitungan kami	Periode kajian Jun 2026 – Feb 2027	Kekeringan dan kekurangan air (musim kemarau Nov–Feb), disusul DBD dan diare pada anak

16 rekomendasi: 0 terkonfirmasi tanpa koreksi, 10 dikoreksi, 5 belum terverifikasi, 1 kontraindikasi pada besaran yang diusulkan. Tiga butir yang belum terverifikasi dibawa dari putaran 28 September tanpa diperiksa ulang. **Target pendanaan turun lebih dari sepertiga dibandingkan laporan 28 September** (US$88.700 → US$55.500), karena alokasi melalui dana desa dipangkas sesuai

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

RINGKASAN EKSEKUTIF — SEKILAS



3,64°LS 128,25°BT, Indonesia · Natural Earth

- **Risikonya.** Air yang ditampung selama kemarau panjang menjadi tempat berkembang biak nyamuk DBD, dan pasien DBD di Maluku meninggal dengan angka tertinggi di Indonesia; setelah El Niño 2015, Ambon mencatat 4 kematian akibat DBD pada Januari–April 2016, dua di antaranya di Passo.
- **Aksi pertama.** Dinkes Kota Ambon dan Puskesmas Passo menyiapkan puskesmas untuk menangani DBD paling lambat 1 November 2026, dipertahankan hingga November 2027, dengan jalur rujukan tertulis ke RSUD Haulussy.
- **Dananya.** Batas bawah US$30.000, target US$55.500, batas atas ~US$107.000; alokasi teratas adalah US$20.000 untuk Puskesmas Passo bagi saringan air atau klorin, wadah air bertutup, dan oralit untuk rumah tangga dengan balita.
- **Jangan.** Jangan hentikan penanganan ketika hujan kembali turun: kematian tahun 2016 terjadi setelah kekeringan, dan musim DBD normal Ambon pada Juni–November datang setelah musim hujan.

Apa yang perlu dilakukan	**9** aksi	p. 2
Siapa mengerjakan apa	bagan RACI	p. 10
Di mana dana paling berdaya guna	pendanaan	p. 10
Jangan lakukan ini	**5** butir	p. 12
Apa yang pernah terjadi di sini	catatan kejadian	p. 14
Bagaimana laporan ini disusun	metodologi	p. 16
Referensi	sumber	p. 17

kemampuan saluran tersebut menyerap dana. Angka paparan: Climate Impact Lab, *451,000 at Risk*, September 2026, belum ditelaah sejawat; hanya panas. **Angka Kota Ambon adalah hitungan kami, bukan temuan Impact Lab:** 19.300 × 357.289 ÷ 281.603.800 ≈ 24,5. Belum ada kajian hubungan suhu–kematian untuk wilayah ekuatorial lembap di Indonesia yang dapat dijadikan pembanding, dan suhu rata-rata bulanan di sini hanya 25–27 °C. **Apa yang berubah sejak 28 September:** BMKG kini menetapkan Kota Ambon pada status *Waspada* untuk awal Oktober; Ambon masih belum menetapkan status apa pun; Maluku masih berada di luar operasi kekeringan IFRC; dan bukti baru menempatkan tata laksana kasus DBD di urutan teratas.

APA YANG PERLU DILAKUKAN WILAYAH INI — BERPERINGKAT

Diurutkan berdasarkan perkiraan jumlah nyawa yang diselamatkan per satuan upaya sebelum dan selama puncak. Sudut pandang pakar yang mendukung ditampilkan pada setiap aksi. Kesepakatan antarpakar diperiksa terhadap bias bersama. Bagan RACI di bawah menetapkan pelaksana setiap aksi.

1. Siapkan Puskesmas Passo untuk menangani DBD sejak November 2026 hingga November 2027, dengan jalur rujukan tertulis ke RSUD Haulussy

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | KESEHATAN MASYARAKAT · SEJARAWAN · KEDARURATAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DIKONSULTASIKAN

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Dinkes Kota Ambon dan Puskesmas Passo; Dinkes Provinsi Maluku untuk RSUD dr. M. Haulussy	Siap paling lambat 1 Nov 2026; dipertahankan hingga Nov 2027	Pelatihan dan cadangan cairan infus; belum dihitung	Kasus DBD berujung pada kematian

Latih tenaga kesehatan dalam triase tanda bahaya sesuai pedoman WHO, sediakan cadangan cairan infus kristaloid dan pemeriksaan hematokrit, dan sepakati secara tertulis siapa merujuk pasien mana ke Haulussy dan bagaimana caranya. **Maluku melaporkan insidensi DBD terendah di Indonesia, tetapi angka kematian kasus tertinggi pada sebagian besar tahun sejak 2010** (Sasmono et al. 2026).

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Catatan Ambon sendiri sejalan: pada Januari–April 2016, setelah El Niño kuat terakhir, kota ini mencatat 37 kasus dan 4 kematian, dua di antaranya di Passo. Di tempat tenaga klinis dilatih menangani DBD, angka kematian kasus turun (Timor-Leste dari 12% menjadi 3,6%; Bangladesh dari 1,81% menjadi 0,95%).*

Koreksi: puncak DBD yang biasa di Ambon adalah Juni–November (Sasmono), sehingga kesiapan tidak dapat dibatasi pada Januari–April; lonjakan pascakekeringan dan musim normal sama-sama harus dicakup. DBD di Maluku lebih mengikuti Indian Ocean Dipole (ρ 0,60) daripada El Niño (Djaafara 2026). Haulussy adalah rumah sakit provinsi yang pada Juli 2026 diminta oleh pemerintah provinsi untuk dibantu penataannya oleh RS Fatmawati, sehingga ujung rujukan itu sendiri merupakan risiko kapasitas. Bukti pelatihan berasal dari studi sebelum-sesudah, bukan uji coba. Jumlah tempat tidur dan stok di Puskesmas Passo belum diverifikasi.

2. Wali Kota menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan sekitar 20 Oktober, berdasarkan kajian BPBD tentang kegagalan pasokan air

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | KEDARURATAN · EKONOM · SEJARAWAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DIKONSULTASIKAN

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Wali Kota Bodewin Wattimena, berdasarkan kajian BPBD Kota Ambon	**~20 Okt 2026**	**Tanpa biaya untuk ditandatangani; membuka cadangan darurat Rp 10 miliar (BTT)**	**Truk tangki dan dana tertahan urusan administrasi pada bulan Desember**

Penetapan status inilah yang membuka jalur kebencanaan ke pos belanja tidak terduga kota dan memungkinkan BPBD mengajukan Dana Siap Pakai BNPB. Peringatan dini BMKG untuk dasarian pertama Oktober kini menempatkan Kota Ambon pada status *Waspada*; pada 28 September Ambon belum tercantum. Kota Tual telah menetapkan Siaga Darurat pada 6–8 September dan sudah menyalurkan air. Ambon belum menetapkan apa pun; pernyataan Wali Kota pada bulan Agustus menjanjikan penyaluran air tanpa status, anggaran, atau jumlah truk tangki.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Koreksi: Ambon berada pada tingkat terendah di Maluku (delapan wilayah berstatus *Awas*), sehingga alasannya harus bertumpu pada kegagalan pasokan air, bukan curah hujan semata. Dasar hukumnya (UU 24/2007 dan peraturan pelaksananya) serta angka cadangan Rp 10 miliar tidak dapat diperiksa ulang pada putaran ini.

3. Petakan sumber air setiap lingkungan di Passo, kontrak truk tangki lebih awal, dan umumkan jadwal tetap paling lambat 31 Oktober yang mendahulukan wilayah dataran tinggi, Waimahu, dan Taholah

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | KEDARURATAN · GARDA DEPAN · SKEPTIS · SEJARAWAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DIKONSULTASIKAN

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
BPBD Kota Ambon bersama PDAM Tirta Yapono; ketua RT dan Pemerintah Negeri Passo untuk pemetaan	Peta paling lambat 20 Okt; jadwal diumumkan paling lambat 31 Okt	Rp 150–300 ribu per muatan 5.000 L (belum terverifikasi); ~Rp 150–250 juta untuk Nov–Feb (perkiraan pakar)	Air hanya sampai kepada siapa yang lebih dulu menelepon, dan rumah tangga beralih ke sumber air yang tidak aman

Pemkot dan BWS Maluku menyebut "dataran tinggi" sebagai wilayah paling berisiko, tanpa menyebut lingkungan mana. Waimahu dan Taholah di Passo baru mendapatkan titik akses air bersih umum pada pertengahan 2025 setelah menunggu puluhan tahun. Umumkan jadwal melalui ketua RT, dan uji atau klorinasi air truk tangki di titik penggunaan, alih-alih menganggapnya aman.*

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Koreksi: titik air dibuka pada 31 Juli 2025 menurut situs negeri ("26 tahun") atau 2 Agustus 2025 menurut Antara ("19 tahun"); kedua sumber dikutip. Badan usahanya adalah Perumda Air Minum Tirta Yapono, yang biasa disebut PDAM Tirta Yapono. Angka E. coli 69% yang dikutip salah satu pakar berasal dari kajian lain (Irianto 2021); hasil Hansen 2026 adalah 21,2% dari 619 rumah tangga di atas 100 CFU/100 mL, dan bukan khusus Ambon. Pemkot mengirim empat truk tangki ke Batu Merah pada Januari 2026 dan memiliki satu unit dari BNPB sejak Desember 2025, jadi danai biaya operasional, bukan truknya.

4. Berikan saringan air atau klorin serta wadah air bertutup dan berkeran kepada rumah tangga dengan balita, dan sediakan oralit melalui kader posyandu

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | KESEHATAN MASYARAKAT · FILANTROPIS · SKEPTIS | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DIKONSULTASIKAN

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Dinkes Kota Ambon; Puskesmas Passo dan kader posyandu	**Bersamaan dengan jadwal truk tangki, sebelum November**	**Alokasi US$20.000 (lihat pendanaan)**	**Diare pada anak akibat air tampungan dan air truk tangki**

Saringan air menurunkan diare yang dilaporkan kira-kira separuhnya (RR 0,48, IK 95% 0,38–0,59; saringan keramik RR 0,39), dan klorinasi menurunkannya sekitar seperempat (RR 0,77) (Clasen et al. 2015, Cochrane). Di tempat oralit dipromosikan, kematian akibat diare turun 69% (Munos et al. 2010). Prevalensi diare balita di Maluku adalah 13,38% (survei 2017), tertinggi pada usia satu tahun, dan prevalensi stunting di Kota Ambon 20,7%.*

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Koreksi: perkirakan penurunan diare yang dilaporkan kira-kira separuhnya; dampak terhadap kematian belum pasti. Perkiraan kematian yang disesuaikan dari GiveWell (14%) hanya berlaku untuk klorinasi dan tidak signifikan secara statistik. Angka 69% adalah efek program gabungan, bukan oralit saja. Zinc tetap dicantumkan sebagai praktik standar, tetapi tidak ada sumber yang diverifikasi pada putaran ini. Uji Cochrane sebagian besar tidak tersamar dengan hasil yang dilaporkan sendiri. Angka prevalensi Maluku sudah berumur sembilan tahun dan berlaku untuk seluruh provinsi.

5. Program wadah air yang benar-benar berhasil: tutup pabrikan yang pas atau tangki berkeran, sikat penggosok, dan pemeriksaan mingguan oleh juru pemantau jentik yang terlatih dan diawasi, hingga Agustus 2027

TERKONFIRMASI SEBAGIAN

SKEPTIS · SEJARAWAN · KESEHATAN MASYARAKAT · GARDA DEPAN · KEDARURATAN

ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DIKONSULTASIKAN

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Kader posyandu dan jumantik (juru pemantau jentik) bersama Puskesmas Passo; Pemerintah Negeri Passo ikut mendanai	**Mulai Oktober; dipertahankan hingga Agustus 2027**	**Alokasi US$17.500 ditambah dana desa (lihat pendanaan)**	**Air tampungan musim kemarau menjadi wabah DBD berikutnya**

Setiap wadah yang ditambahkan dalam penanganan kekeringan adalah tempat berkembang biak nyamuk sampai tutup yang pas dan pengurasan mingguan membuktikan sebaliknya. Kekeringan parah meningkatkan risiko DBD 1,85 kali lipat di seluruh Asia Tenggara, dengan efek kedua sekitar dua bulan kemudian seiring berubahnya kebiasaan menampung air (Ith et al. 2025). Penggerakan masyarakat tanpa bahan kimia menurunkan infeksi dengue 29,5% dalam uji Camino Verde (Nikaragua dan Meksiko), dan temefos tidak menambah manfaat apa pun di sana. Di Yangon, tutup seadanya saja masih menyisakan 14,8% wadah positif jentik pada musim kemarau; tutup ditambah pembersihan mingguan menurunkannya menjadi nol.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Koreksi: larvasida (temefos, "abate") hanya sebagai tambahan, setelah uji hayati (bioassay) WHO pada jentik dari Ambon. Resistansi telah terdokumentasi di berbagai wilayah Indonesia (Surabaya, Padang, Pekanbaru, dan lainnya), dan Maluku belum pernah diuji. Juru pemantau perlu pelatihan dan pengawasan: di Malang hanya 48,3% yang memiliki pengetahuan keseluruhan yang baik dan 52,2% yang memeriksa secara rutin. Seluruh bukti uji coba berasal dari Amerika Latin dan Myanmar.

6. PMI Kota Ambon menyampaikan data kebutuhan yang terverifikasi ke PMI Pusat agar IFRC dapat memasukkan Maluku ke dalam operasi kekeringan Indonesia (MDRID030)

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | EKONOM · KEDARURATAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DIKONSULTASIKAN

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
PMI Kota Ambon melalui PMI Maluku dan PMI Pusat	**Paling lambat 15 Okt 2026; operasi berjalan hingga 31 Mar 2027**	**Waktu staf**	**Ambon tertinggal dari satu-satunya dana kekeringan yang sudah disiapkan sebelumnya**

Operasi ini (US$120.284, 200.000 orang, 25 September 2026 – 31 Maret 2027) mencakup 20 provinsi dalam tiga tingkat prioritas; kata "Maluku" tidak muncul dalam 26 halamannya. Laporan pemicunya sendiri menyebut curah hujan rendah diperkirakan terjadi di "Sulawesi, Maluku and parts of Papua", dan dokumen itu menyatakan perubahan cakupan dilakukan melalui Operations Update. Itulah celahnya.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Dana yang realistis kecil: sekitar US$0,60 per orang jika dibagi rata, dan ini hasil pembagian kami, bukan perhitungan biaya. PMI harus terlebih dahulu mendokumentasikan kebutuhan air berdasarkan kriteria penargetan operasi tersebut.

7. Satu pesan dalam Melayu Ambon, disepakati oleh Raja dan Saniri, disampaikan melalui jemaat GPM dan, melalui ikatan pela, melalui imam Batumerah; serta satu kader yang ditunjuk untuk setiap lansia yang hidup terisolasi

BELUM TERVERIFIKASI (DAMPAK) | GARDA DEPAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DIKONSULTASIKAN

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Raja Negeri Passo dan Saniri; jemaat GPM; kader posyandu; pimpinan masjid Batumerah melalui ikatan pela	Oktober 2026	Waktu relawan	Peringatan hanya sampai ke satu komunitas

Pesannya: "tutup tampayang, kuras tiap minggu" (tutup tempayan air, kuras setiap minggu), ke mana melaporkan gangguan air, tanda-tanda bahaya DBD, dan kapan anak harus dibawa berobat. Passo (nama adat Paukala Mandalise) terikat pela, sebuah persekutuan berusia sekitar 500 tahun, dengan Batu Merah, negeri yang mayoritas penduduknya Muslim; ketiga negeri memperbaruinya dalam acara *makan patita* bersama pada 18 Mei 2024 yang dihadiri Wali Kota. Menyampaikan satu pesan melalui keduanya adalah cara agar pesan itu menjangkau kedua komunitas tanpa terkesan berasal dari salah satunya.*

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Fakta-faktanya terkonfirmasi; dampaknya belum. Tidak ada sumber yang menunjukkan saluran pela atau adat pernah dipakai untuk penyampaian pesan kesehatan di Ambon (penanganan COVID-19 di sana dilakukan dari rumah ke rumah), jadi anggaplah ini hipotesis yang masuk akal. Jumlah penduduk Passo sendiri tidak bersumber.

8. Perluas subsidi jaminan kesehatan kota agar peserta yang tidak aktif kembali aktif sebelum musim DBD

TERKONFIRMASI SEBAGIAN — SUDAH BERJALAN | EKONOM · KESEHATAN MASYARAKAT | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DIKONSULTASIKAN

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Pemkot Ambon bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon dan Dinkes	**Pendaftaran sebelum Jan 2027**	**~Rp 6,0 miliar/tahun untuk ~12.000 peserta tambahan (hitungan kami)**	**Keluarga menunda perawatan rumah sakit karena kartunya tidak aktif**

98,25% penduduk terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi hanya 76,78% yang aktif (Sekda, 24 September 2026), di bawah ambang 80%. Pemkot telah mengalokasikan Rp 8,9 miliar dari anggaran 2026 untuk iuran 16.021 orang. Pemanfaatan JKN di Maluku rendah: 14,79% peserta dibandingkan 17,66% secara nasional (2021).

Kaitannya dengan berkurangnya kematian merupakan dugaan, bukan hasil pengukuran. Iuran bulanan Rp 42.000 tidak dapat dicocokkan dengan peraturannya.

Dibawa dari 28 September, tidak diperiksa ulang pada putaran ini

BELUM TERVERIFIKASI PADA PUTARAN INI

Tegakkan imbauan Wali Kota tanggal 15 Agustus tentang larangan membakar hingga Februari, bukan hanya September, bersama Satpol PP dan pos Damkar di Passo, serta sediakan titik pengisian air khusus bagi pemadam kebakaran. **Lindungi mata air Passo dan sabuk mangrovenya yang sekitar 320 m**, uji daya hantar listrik air sumur mana pun sebelum digunakan, dan jangan mengebor sumur bor darurat. **Hitung kematian setiap minggu, digabung untuk seluruh Kota Ambon**, melalui Dinkes dan Disdukcapil, karena Passo saja terlalu kecil untuk menunjukkan perubahan.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

SIAPA MENGERJAKAN APA

BAGAN RACI

R = Responsible/Pelaksana (mengerjakan) · **A** = Accountable/Penanggung jawab akhir (satu per aksi; menyetujui dan bertanggung jawab atasnya) · **C** = Consulted/Dikonsultasikan (dimintai pendapat sebelumnya) · **I** = Informed/Diinformasikan (diberi tahu sesudahnya). Disusun dari penanggung jawab yang disebut dalam aksi-aksi yang telah diverifikasi. Belum ada pihak yang dihubungi atau menyetujui perannya; setiap baris adalah usulan.

Aksi	Wali Kota / Pemkot	BPBD Kota Ambon	Dinkes Kota Ambon	Puskesmas Passo	RSUD Haulussy / Dinkes Prov.	PDAM Tirta Yapono	Negeri Passo (Raja & Saniri)	Ketua RT	Kader posyandu & jumantik	GPM & masjid Batumerah (pela)	PMI (Kota / Pusat)	IFRC	BPJS Kesehatan	BMKG	Damkar / Satpol PP
1. Kesiapan tata laksana kasus DBD	I		A	R	R		I		I				C		
2. Penetapan status darurat kekeringan	A	R	C			C	I	I			I			C	
3. Peta sumber air, truk tangki, jadwal	I	A	C	C		R	R	R	I	I	C				
4. Pengolahan air, wadah air, dan oralit untuk rumah tangga dengan balita			A	R			C	I	R						
5. Tutup yang pas, pemeriksaan mingguan, larvasida hanya setelah uji hayati		I	A	R			R	I	R	I					
6. Memasukkan Maluku ke operasi kekeringan IFRC	I	C									R	A		C	
7. Satu pesan melalui adat, gereja, masjid; kader untuk lansia			I	C			A	R	R	R					
8. Perluasan subsidi iuran JKN	A		R	I			I						R		
Dibawa: penegakan larangan membakar, titik air pemadam	I	A				C	C	I							R

Apa yang ditunjukkan bagan ini. **Dinkes Kota Ambon menjadi penanggung jawab akhir untuk tiga dari delapan aksi inti dan dikonsultasikan untuk dua aksi lainnya**, sehingga Dinkes adalah pertemuan pertama. **Kantor Wali Kota menjadi penanggung jawab akhir untuk penetapan status darurat dan perluasan subsidi jaminan kesehatan**, yang membuka sebagian besar dana publik. **Pemerintah Negeri Passo adalah satu-satunya lembaga yang sekaligus menjadi Pelaksana dan penyandang dana di tingkat negeri**, melalui dana desanya.

DI MANA DANA PALING BERDAYA GUNA

PENDANAAN

Sudut pandang Filantropis, yang diselaraskan dengan aksi-aksi berperingkat dan telah diverifikasi. Alokasi diurutkan berdasarkan tambahan nyawa yang diselamatkan per dolar. Besaran dana dibatasi oleh apa yang dapat dibelanjakan wilayah ini sebelum puncak, bukan oleh kebutuhannya. Belum ada dana yang disiapkan sebelumnya untuk Ambon: operasi kekeringan IFRC tidak mencakup Maluku, dan cadangan darurat kota menunggu penetapan status.

BATAS BAWAH TARGET BATAS ATAS KETIDAKPASTIAN TERBESAR

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

US$30.000 (alokasi 1 dan 3)	**US$55.500**	**~US$107.000**	**Jumlah penduduk Passo dan alokasi dana desanya; keduanya tidak dipublikasikan**

Target = US$20.000 + US$17.500 + US$10.000 + US$8.000. Batas atas = rata-rata alokasi dana desa per negeri di Kota Ambon (~US$69.000: Rp 33,81 miliar ÷ 30 desa pada 2025, hasil pembagian kami), saluran terbesar yang terbukti mampu membelanjakan dana, ditambah US$20.000 + US$10.000 + US$8.000. **Target turun dari US$88.700 (28 September) dan dari US$73.000 usulan pakar**, karena dana pendamping US$35.000 akan menyerap sekitar separuh perkiraan alokasi dana desa Passo, dan dana desa adalah dana transfer, bukan instrumen dana pendamping.

PENERIMA	PENGGUNAAN	JUMLAH	MEKANISME	DASAR	PUTUSAN
Puskesmas Passo, melalui Dinkes Kota Ambon	Aksi 4: saringan air atau klorin, wadah air bertutup, oralit untuk rumah tangga dengan balita (tidak termasuk Waimahu dan Taholah, yang kini terlayani titik air umum)	US$20.000	Pengadaan barang, dilaporkan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Saringan air RR 0,48 untuk diare (Clasen 2015); jumlah ditetapkan berdasarkan daya serap saluran, bukan biaya satuan	Terkonfirmasi sebagian; tidak ada catatan belanja pada skala ini
Pemerintah Negeri Passo bersama jumantik	Aksi 5: tutup yang pas, sikat, pemeriksaan mingguan	US$17.500	Hibah terikat, berdampingan dengan pos dana desa milik negeri sendiri	Camino Verde US$7,47–16,72 per orang-tahun (Nikaragua–Meksiko); dengan tarif itu mencakup sekitar 2.300–4.700 orang selama lima bulan	Dikoreksi (sebelumnya US$35.000 sebagai dana pendamping 1:1: kontraindikasi pada besaran itu)
BPBD / Pemkot Ambon	Aksi 3: biaya operasional truk tangki untuk Passo	US$10.000	Cadangan siaga, dicairkan setelah penetapan status	≈ Rp 163 juta ÷ Rp 250.000 per muatan ≈ 652 muatan (harga belum terverifikasi)	Terkonfirmasi sebagian; danai operasional, bukan truk

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

PENERIMA	PENGGUNAAN	JUMLAH	MEKANISME	DASAR	PUTUSAN
Posyandu lansia; diakonia GPM dapat menjadi mitra pelaksana	Aksi 7: pemeriksaan mingguan bagi lansia yang hidup terisolasi	US$8.000	Hibah langsung	Tidak ditemukan kajian efektivitas biaya	Belum terverifikasi

Satu hal terpenting bagi penyandang dana: hambatannya adalah saluran, bukan uang. Danai hanya apa yang terbukti dapat dibelanjakan suatu lembaga dalam lima bulan, dan langkah termurah bukanlah hibah: langkah itu adalah memasukkan Maluku ke dalam operasi IFRC (aksi 6) dan mendapatkan tanda tangan Wali Kota pada penetapan status darurat (aksi 2). BAZNAS Kota Ambon hanya menyalurkan Rp 244,1 juta sepanjang 2024 untuk seluruh programnya, sehingga lembaga ini tidak dapat menanggung lebih dari permintaan oralit yang kecil.

JANGAN LAKUKAN INI — KONTRAINDIKASI

Saran yang beredar untuk bahaya ini dan justru dapat merenggut nyawa di sini.

Pengasapan (fogging) atau temefos (abate) sebagai penanganan DBD yang utama

KONTRAINDIKASI

Resistansi terhadap piretroid meluas pada *Aedes aegypti* di Indonesia (Ridha et al. 2025), dan resistansi atau toleransi terhadap temefos telah terdokumentasi di Surabaya, Padang, Pekanbaru, Kuningan, Toraja, dan Jawa Tengah (Kasman et al. 2025). Belum ada yang mengujinya di Maluku. Dalam uji Camino Verde, temefos tidak menambah perlindungan.

Sebagai gantinya: tutup yang pas, pengurasan mingguan, pemeriksaan yang diawasi (aksi 5); lakukan fogging hanya di sekitar klaster kasus yang terkonfirmasi, dan beli larvasida hanya setelah uji hayati setempat.

Membagikan drum atau tutup seadanya, atau membangun tangki air hujan terbuka pada musim ini

KONTRAINDIKASI

Tutup yang tidak pas tetap menjadi tempat berkembang biak nyamuk (14,8% positif jentik di Yangon), dan tangki terbuka yang dibangun sekarang hampir tidak menampung air sebelum hujan kembali pada April–Mei, sementara itu menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Sebagai gantinya: tutup pabrikan yang pas atau tangki berkeran, disertai sikat dan jadwal pemeriksaan.

Menganggap air truk tangki aman*

KONTRAINDIKASI

Truk tangki sering diisi dari sumur, dan air tanah yang diambil sendiri oleh warga perkotaan di Indonesia sering tercemar (21,2% dari 619 rumah tangga di atas 100 E. coli per 100 mL dalam Hansen 2026; bukan data Ambon).

Sebagai gantinya: uji sumber pengisian, lakukan klorinasi di titik penggunaan, dan sertakan oralit pada setiap pengiriman untuk rumah tangga dengan anak kecil.

Menghentikan penanganan ketika hujan kembali turun

KONTRAINDIKASI

Kematian tahun 2016 terjadi setelah kekeringan, dan dampak kekeringan terhadap DBD berulang sekitar dua bulan kemudian seiring berubahnya kebiasaan menampung air. Musim DBD normal Ambon (Juni–November) datang setelah musim hujan.

Sebagai gantinya: pertahankan pemeriksaan wadah air dan kesiapan klinis setidaknya hingga Agustus 2027.

Dana pendamping 1:1 yang besar dari dana desa untuk program wadah air

KONTRAINDIKASI PADA BESARAN INI

Dana Desa adalah transfer nasional, bukan dana pendamping. Dana pendamping US$35.000 akan menyerap sekitar separuh perkiraan alokasi tahunan Passo, yang 20%-nya sudah diperuntukkan bagi ketahanan pangan, dan akan tetap tidak terbelanjakan hingga musim kemarau berlalu.

Sebagai gantinya: hibah US$17.500 berdampingan dengan anggaran apa pun yang disusun negeri melalui siklus perencanaannya sendiri.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

APA YANG PERNAH TERJADI DI SINI

CATATAN KEJADIAN

TAHUN	KEJADIAN	DAMPAK	APA YANG BERUBAH SESUDAHNYA
1997 (El Niño, ONI +2,4)	Curah hujan Agu–Okt 3, 1, dan 7 mm dibandingkan normal 347, 231, dan 132 mm	Tidak tercatat	Tidak terdokumentasi
1999–2004	Konflik Maluku	Ribuan jiwa di seluruh Maluku	Permukiman Kristen dan Muslim terpisah; ikatan pela menjadi jembatan
2016 (setelah El Niño 2015)	DBD, Jan–Apr	37 kasus, 4 kematian di Ambon; 2 kematian di Passo	Dinas kesehatan menyalahkan wadah air yang tidak bertutup
2021	Kajian Ombudsman tentang air di Ambon	Pasokan ~30% dari kebutuhan, turun hingga 60% pada musim kemarau (tidak diperiksa ulang)	Hilangnya daerah tangkapan air akibat perumahan disebut; tidak dipulihkan
2023 (El Niño, ONI +2,0)	Penggiliran air pada musim kemarau	Pelanggan di Batu Merah mendapat pasokan seminggu sekali	Sumur dalam ditambah di bagian lain kota
Jul–Agu 2025	Titik air umum dibuka di Waimahu dan Taholah, Passo	Setelah 19–26 tahun tanpa akses	Pasokan air umum pertama untuk dusun-dusun tersebut
Des 2025 – Jan 2026	Kapasitas truk tangki ditambah	—	Unit BNPB untuk Ambon; empat truk tangki ke Batu Merah
Agu – Okt 2026	Imbauan larangan membakar (15 Agu); Tual menetapkan darurat kekeringan (Sep); BMKG menempatkan Ambon pada status *Waspada* (Okt)	—	Ambon belum menetapkan status

Pola berulang yang belum disadari siapa pun: keadaan darurat El Niño di Ambon dimulai ketika di wilayah Indonesia lainnya berakhir. Hujan secara nasional tiba pada November, tepat ketika Ambon memasuki musim kemaraunya sendiri, dan DBD menyusul pada awal tahun dan

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

kembali sepanjang musim Juni–November. Penanganan yang mengikuti kalender nasional akan berhenti tepat sebelum bulan-bulan paling mematikan bagi Passo.

DI MANA PARA PAKAR BERBEDA PENDAPAT — BELUM TERSELESAIKAN

- **Gunakan larvasida abate pada air tampungan** (Pengelola kedaruratan) versus **resistansi larvasida meluas di Indonesia dan belum diuji di Maluku** (Skeptis). Diselesaikan sebagai syarat: tidak ada pembelian larvasida sampai ada uji hayati WHO pada jentik dari Ambon.
- **Pengendalian vektor lebih dulu** (peringkat 28 September) versus **tata laksana kasus lebih dulu, karena masalah Maluku adalah angka kematian kasus, bukan jumlah kasus** (Kesehatan masyarakat). Putaran ini menempatkan tata laksana kasus di urutan pertama; keduanya tetap ada dalam rencana.
- **Periode risiko DBD Januari–April** (Sejarawan, 2016) versus **puncak yang biasa di Ambon pada Juni–November** (Sasmono 2026). Keduanya nyata; kesiapan kini berlangsung dari November 2026 hingga November 2027.

APA YANG TIDAK DICAKUP SIAPA PUN — TITIK BUTA

Tidak ada pakar yang dapat melihat **ke dalam Puskesmas Passo atau Haulussy**: tempat tidur, stok cairan infus, tenaga yang terlatih menangani DBD, atau berapa lama rujukan benar-benar berlangsung. Jika tata laksana kasus adalah pengungkitnya, kapasitas itulah fakta penentunya, dan Haulussy sedang berada di bawah dukungan manajemen dari luar. Tidak ada pula yang mengetahui **jumlah penduduk Passo atau alokasi dana desanya**, yang menentukan besaran setiap alokasi. Dan tidak ada sumber yang memberikan **jumlah kasus DBD atau diare tahun 2026** untuk Ambon. Satu kunjungan ke Puskesmas dan satu panggilan telepon ke Dinkes akan menjawab ketiganya.

CARA MEMBACA LAPORAN INI — METODE

Panel pakar disusun oleh penulis. Tujuh sudut pandang pakar simulasi digunakan untuk menghasilkan rekomendasi ini. Bila mereka sepakat, itu merupakan hipotesis yang kuat, bukan konsensus bidang keilmuan. Setiap rekomendasi kemudian diperiksa secara independen dari segi bukti, keterterapan di lokasi ini, dan kelayakan sebelum puncak; label putusan memuat hasilnya.

Angka kematian dihitung pada skala wilayah dampak Climate Impact Lab, sekitar 300.000 jiwa. Angka ini bukan angka tingkat lingkungan. Proyeksi El Niño hanya mencakup *panas*; kekeringan, banjir, kebakaran, asap, dan gagal panen merupakan tambahan di luarnya dan dalam

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

laporan ini diwakili oleh catatan sejarah, bukan oleh angka yang dipublikasikan. Panas itu sendiri tidak terlalu tinggi di sini (rata-rata bulanan 25–27 °C); kipas angin aman digunakan di bawah 35 °C (Meade et al. 2024).

BAGAIMANA LAPORAN INI DISUSUN METODOLOGI

- **Cakupan.** Lokasi diterima sebagaimana diberikan: Negeri Passo, sebuah negeri adat di Kecamatan Baguala (sebagaimana disebut oleh Kemendagri dan negeri itu sendiri; Pemkot dan BPS menggunakan Teluk Ambon Baguala), Kota Ambon, Maluku. Ini adalah putaran ulang dari laporan 28 September 2026, atas permintaan Angus dengan tambahan bagan RACI. Wilayah dampak Climate Impact Lab, sebagaimana dicatat dalam laporan: tidak teridentifikasi. Angka kematian hanya tersedia pada skala tersebut (wilayah dampak rata-rata berpenduduk sekitar 300.000 jiwa); rincian di bawah tingkat kota digunakan untuk paparan bahaya dan perancangan aksi, bukan untuk jumlah kematian.
- **Paparan.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (September 2026, belum ditelaah sejawat): prakiraan musiman ECMWF SEAS5 (ansambel 51 anggota) yang diterapkan pada hubungan suhu–kematian di 24.378 wilayah, terhadap garis dasar 1996–2025, untuk Juni 2026 – Februari 2027. Data ini hanya mencakup panas. Angka ini tidak pernah dijumlahkan dengan proyeksi jangka panjang Impact Map, dan tidak dikutip dari angka kematian berbasis PDB pada peta tersebut. Jika panas bukan bahaya utama, catatan sejarah yang mewakili bahaya tersebut, bukan angka pinjaman.
- **Panel pakar.** Tujuh sudut pandang pakar simulasi (pengelola kedaruratan, ilmuwan kesehatan masyarakat, petugas garda depan, skeptis, ekonom, sejarawan, dan filantropis) masing-masing meneliti tempat ini secara mandiri dan paralel, dari sumber daring, berdasarkan arahan yang sama. Masing-masing diberi temuan 28 September untuk diperiksa dan diperbarui, bukan diulang.
- **Penyelarasan.** Aksi yang sama digabungkan dan sudut pandang pendukungnya dicatat. Kesepakatan diuji terhadap bias bersama (apakah bukti di balik aksi yang disepakati berasal dari kondisi yang serupa dengan tempat ini) sebelum dihitung sebagai pendukung suatu aksi. Pertentangan dipertahankan, tidak diselesaikan dengan membuang salah satu pihak. Aksi diurutkan berdasarkan perkiraan nyawa yang diselamatkan per satuan upaya sebelum puncak, masing-masing diberi pembayar dan pemicu yang jelas atau ditandai belum didanai, dan alokasi pendanaan diselaraskan dengan daftar berperingkat. Bagan RACI disusun dari penanggung jawab yang disebut dalam aksi-aksi yang telah diverifikasi.
- **Verifikasi.** Lima agen verifikator memeriksa 13 dari 16 rekomendasi dengan tiga uji: bukti (sumber primer dan besaran efeknya), keterterapan (apakah bukti itu berasal dari tempat yang serupa dengan di sini), dan kelayakan (apakah aksi itu dapat dilakukan di sini sebelum puncak). Aksi keuangan juga diperiksa ketersediaannya di yurisdiksi ini, pembayar yang jelas, ambang pemicu, dan apakah sudah ada. Besaran pendanaan diperiksa terhadap penerima yang nyata, biaya satuan yang dipublikasikan, dan duplikasi, lalu dijumlahkan ulang. Tiga butir yang dibawa dari 28 September tidak diperiksa ulang.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

- **Putusan.** *Terkonfirmasi*: bukti, keterterapan, dan kelayakan seluruhnya terpenuhi. *Terkonfirmasi sebagian*: terpenuhi setelah koreksi yang ditunjukkan. *Belum terverifikasi*: tidak dapat ditelusuri ke sumber primer. *Kontraindikasi*: akan merugikan atau menyia-nyiakan waktu yang tersedia di sini.
- **Adaptation Inventory.** Tidak dikonsultasikan pada putaran ini: kuota pencarian web telah habis, dan unduhannya berada di balik formulir pendaftaran. Putaran 28 September tidak menemukan entri DBD untuk Indonesia.
- **Rumusan kesehatan.** Bagian yang kesalahan rumusannya dapat membahayakan seseorang (tanda bahaya DBD dan kapan harus mencari perawatan, pengolahan air, dan oralit) ditandai "* * Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan." Bagian ini diperiksa berdasarkan sumber yang dipublikasikan, bukan oleh tenaga kesehatan profesional. Isinya adalah usulan, bukan nasihat medis, dan siapa pun yang meneruskannya sebaiknya memastikannya terlebih dahulu kepada dokter, apoteker, perawat, atau kader kesehatan. Penanda ini ditambahkan pada 2 November 2026.
- **Aturan.** Tidak ada biaya yang diperoleh dengan membagi suatu total yang dipublikasikan, dan tidak ada angka lokal yang dikarang; bila data terbatas, laporan menyatakannya dan menampilkan angka wilayah induk beserta perhitungannya. Setiap sumber dicantumkan di bawah beserta status verifikasinya.
- **Keterbatasan.** Panel dan verifikator adalah agen riset AI yang bekerja dari sumber yang tersedia di web, bukan pakar manusia, dan tidak ada orang di tempat ini yang diwawancarai. Kesenjangan khusus putaran ini: pencarian web tidak tersedia (agen mengambil halaman secara langsung); BPS, BNPB, Kompas, ReliefWeb, dan basis data peraturan BPK mengembalikan galat 403; jumlah penduduk Passo, alokasi dana desanya, kapasitas Puskesmas Passo, jumlah kasus DBD 2026, harga truk tangki, dan angka BTT belum diverifikasi; angka "17 kasus DBD pada 2023" dihapus karena tidak bersumber.
- Bagian yang ditandai "rumusan usulan" adalah petunjuk keselamatan hasil terjemahan yang belum diperiksa oleh tenaga kesehatan penutur asli.

Referensi · DBD: Sasmono et al. 2026, Djaafara et al. 2026, DBD Ambon 2016, Ith et al. 2025, pelatihan tata laksana kasus, Camino Verde (Andersson et al., BMJ 2015), Tschampl et al. 2020, tutup wadah di Yangon, jumantik Malang, Kasman et al. 2025 (terkonfirmasi, dikoreksi) · Air dan kesehatan: Clasen et al. 2015 (Cochrane CD004794.pub3), Munos et al. 2010, GiveWell, kualitas air, Siramaneerat 2026, Hansen 2026 (terkonfirmasi, dikoreksi) · Kekeringan dan penetapan status: peringatan dini kekeringan BMKG, penetapan status di Tual, koordinasi Pemkot–BWS, titik air Waimahu dan Taholah, situs Negeri Passo (terkonfirmasi) · Keuangan: dokumen IFRC MDRID030, laporan pemicu IFRC, JKN Rp 8,9 miliar, Titaley et al. 2025, peringkat Dana Desa, BAZNAS 2024 (terkonfirmasi, dikoreksi) · Tempat: Teluk Ambon Baguala, makan patita pela 2024 (terkonfirmasi) · Musim: Curah hujan UNPATTI 1959–2018; ENSO: NOAA ONI · Panas: Meade et al. 2024
Data paparan · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Disusun pada 2 Oktober 2026 untuk Passo, Baguala, Kota Ambon, Indonesia (putaran ulang dari 28 September). El Niño Ready dijalankan oleh relawan dan tidak berafiliasi dengan Climate Week NYC, The Climate Group, atau Columbia University.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan